

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1459

10 de septiembre de 2026

Presentado por la señora *Santiago Negrón* y el señor *González Costa*

Referido a la Comisión de

LEY

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 2 y el inciso (g) del Artículo 3 de la Ley 156-2006, según enmendada, denominada “Ley de Acompañamiento durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Post-parto”, a los fines de esclarecer que durante el trabajo de parto, en las salas de parto, en el parto y postparto, la persona parturienta tiene derecho a estar acompañada de la *doula* o persona adiestrada en medidas de comodidad de su elección, además de los familiares o amigos que escoja libremente; y para decretar otras disposiciones complementarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El texto promulgado de la Constitución de Puerto Rico reconoció en su Artículo II, Sección 20 “[e]l derecho de toda mujer en estado grávido o en época de lactancia y el derecho de todo niño, a recibir cuidados y ayudas especiales”. El lenguaje de esta disposición se deriva del Artículo 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas; disposición que no constituye una expresión aislada de la comunidad internacional.¹ La Declaración de Derechos para el Parto (elaborada por organizaciones profesionales de obstetricia y ginecología

¹ “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. Declaración Universal de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Artículo 25.2.

encabezadas por la *International Federation of Gynecology and Obstetrics*, el *Royal College of Obstetricians and Gynaecologists* y el *American College of Obstetricians and Gynecologists*) establece los derechos y cuidados mínimos de atención sanitaria que deben observarse para garantizar la salud materna antes, durante y después del embarazo. Entre otras estipulaciones, el instrumento dispone que a las embarazadas se les debe proporcionar acceso a al menos una acompañante de parto elegida por ella durante el trabajo de parto y el nacimiento, pues el acompañamiento de una persona de su confianza durante el trabajo de parto “marca una diferencia significativa en la seguridad y el bienestar de las mujeres”.² Éste último, el acompañamiento, es un derecho amparado en la literatura científica.

Según estudios auspiciados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud,³ la evidencia indica que el acompañamiento durante el trabajo de parto aumenta los partos vaginales espontáneos; reduce los partos vaginales instrumentales;⁴ reduce la duración del trabajo de parto; reduce la incidencia de cesáreas en un 25%; puede reducir la necesidad de distintos tipos de analgésicos; reduce las valoraciones negativas de la experiencia de parto, un efecto que se multiplica cuando la persona o personas de apoyo no forman parte del personal del hospital; reduce la depresión puerperal; puede contribuir a reducir la incidencia de hipoxia-isquemia perinatal; puede aumentar el uso de la lactancia, con los beneficios para la salud que ésta supone; y produce un ahorro sustancial del costo económico asociado al trabajo de parto.

En cuanto al aspecto valorativo, los estudios cualitativos que exploraron las percepciones y experiencias del acompañamiento en el trabajo de parto indican que las mujeres valoran las medidas de alivio del dolor no farmacológicas que las acompañantes ayudan a facilitar, como el tacto tranquilizador (sujetar la mano, masajes y contrapresión),

² *International Federation of Gynecology and Obstetrics*, Declaración de Derechos para el Parto de 17 de septiembre de 2021: https://www.figo.org/sites/default/files/2021-09/FIGO_Statement_Childbirth_Bill_of_Rights_ES.pdf.

³ Organización Mundial de la Salud & Organización Panamericana de la Salud, *Recomendaciones de la OMS: Cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva*. World Health Organization, 2018; Organización Panamericana de la Salud, 2019: <https://iris.paho.org/server/api/core/bitstreams/cf78c6b5-ccae-4e91-80ed-171a499259ee/content>.

⁴ Los partos vaginales instrumentales son procedimientos en los que el personal médico utiliza herramientas especiales, como la ventosa o el fórceps, para extraer o asistir en la extracción del bebé durante la etapa final del parto.

las técnicas de respiración y de relajación y la asistencia para adoptar posturas alternativas para aliviar el dolor. Algunas mujeres también encuentran consuelo en el apoyo espiritual cuando sus acompañantes les asisten con la lectura de textos sagrados o la recitación de plegarias. Las mujeres inmigrantes o refugiadas, por su parte, resaltan que las acompañantes de su propia comunidad étnica, religiosa o cultural, que han recibido capacitación como acompañantes, son para ellas una forma importante de recibir una atención competente desde el punto de vista cultural. Estas acompañantes empoderan a las mujeres para plantear preguntas, pueden actuar como sus portavoces y se aseguran de que se respeten sus costumbres y tradiciones. Cuando las mujeres reciben este tipo de asistencia, se autoperciben como más seguras y se sienten menos “extrañas” en su nueva comunidad.

A su vez, el acompañamiento estructurado que proveen las *doulas* en el proceso de preparación para el parto y durante el trabajo de parto no solo potencia los beneficios generales del acompañamiento, sino que además genera en las mujeres sentido de control durante el trabajo de parto, por lo cual se sienten más seguras de su capacidad de dar a luz; ayuda a las mujeres a mejorar su autoestima cuando reconocen y refuerzan sus esfuerzos; proporciona estímulo y orientación sobre la forma de mantener el control; asegura que las mujeres sean conscientes de su autonomía y posibilidad de elección; y propicia una tasa aún menor de partos prematuros y cesáreas.

Finalmente, la literatura científica expone que las políticas de los centros de atención de salud que limitan la participación de los familiares, las *doulas* y las asistentes tradicionales en el parto no sólo pueden incidir negativamente sobre la experiencia del parto, sino que inducen ansiedad en muchas mujeres, lo que puede provocar el desarrollo de trastornos de salud mental. Tanto por los beneficios del acompañamiento, como por el efecto nocivo de restringirlo injustificadamente, es medular que los prestadores de atención de salud reciban capacitación sobre la forma de integrar a la persona acompañante en el equipo de apoyo a la mujer. Con la capacitación adecuada, se evitan los conflictos o malentendidos que pudieran suscitarse entre el prestador de atención de salud, la acompañante y la mujer.

En Puerto Rico hay un estatuto vigente que, en términos generales, es congruente con las recomendaciones de la comunidad internacional. La Ley 156-2006, según enmendada, denominada “Ley de Acompañamiento durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Post-parto” reconoce a las mujeres y otras personas gestantes derechos específicos que deben protegerse durante el proceso de parto, aparte de los reconocidos por la Constitución y el ordenamiento internacional sobre derechos humanos. Entre otros derechos, la ley referida contempla el derecho de las personas gestantes a tomar decisiones libres de coerción e informadas sobre el proceso del parto; el derecho a ser tratadas con respeto y de modo individual y personalizado; el derecho a procurar el parto natural como primera alternativa, respetando sus aspectos fisiológicos, biológicos y psicológicos, y evitando prácticas invasivas y suministro de medicamentos que no estén justificados por su estado de salud; el derecho a tener contacto entre la madre y el bebé dentro de la primera hora de nacido; y, según delata su título, el derecho al acompañamiento durante el trabajo de parto. Éste se consagra en el Artículo 3, inciso (g) y señala textualmente que toda mujer embarazada tendrá derecho:

A estar acompañada por personas de su confianza y elección durante el trabajo de parto, en las salas de parto, en el parto y postparto, incluyendo el procedimiento de cesárea, en el cual podrá estar acompañada por al menos una persona de su elección; entendiéndose, sin embargo que la presencia de la(el) acompañante o acompañantes no podrá interferir con las determinaciones de carácter médico que consideren o tomen los profesionales de la salud con responsabilidad en el parto, y en caso del procedimiento de cesárea, serán éstos los que determinarán en última instancia si permiten o no la presencia del acompañante. Además, tendrá derecho a no estar acompañada, si así lo desea la mujer. Disponiéndose que el acompañante vendrá obligado a cumplir con aquellas reglas que tuviere a bien imponer la institución hospitalaria, siempre y cuando dichas reglas sean cónsonas a lo establecido en esta Ley.⁵

A pesar de que el texto de la ley expresamente alude, en plural, a las personas de confianza y elección de la mujer, y de que la ley limita el acompañamiento a una sola

⁵ Énfasis suplido.

persona exclusivamente cuando se practique una cesárea, algunas salas de parto en Puerto Rico hacen una interpretación restrictiva del texto de la ley y operan bajo la premisa de que el derecho al acompañamiento que asiste a las parturientas se limita a permitir la entrada de una sola persona. Bajo esa interpretación, muchas mujeres quedan obligadas a cohibirse de los beneficios probados que provee la asistencia de una *doula* o a perder el apoyo moral, emocional y espiritual de sus familiares, amigos o clérigos, que igualmente es de vital importancia. Ante tal escenario, es la intención de la Asamblea Legislativa esclarecer que una interpretación restrictiva de la “Ley de Acompañamiento durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Post-parto” no es cónsona con la intención legislativa, el espíritu de la ley o su texto establecido. El Artículo 3, inciso (g), en particular, debe entenderse en el sentido de que, durante el trabajo de parto, en las salas de parto, en el parto y postparto, la persona parturienta tiene derecho a estar acompañada de la *doula* o persona adiestrada en medidas de comodidad de su elección, además de los familiares o amigos que escoja libremente. El esfuerzo por subsanar la crisis demográfica que enfrenta Puerto Rico requiere de acercamientos múltiples, desde un sistema sanitario que canalice adecuadamente los derechos de las mujeres, hasta una red de seguridad social que las sostenga con dignidad a lo largo de la vida.

Como último asunto, esta pieza legislativa suprime el vocablo “monitriz” del texto de la ley por considerarse un término en desuso u obsoleto entre las educadoras y acompañantes de procesos de parto.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 2 de la Ley 156-2006, según
2 enmendada, denominada “Ley de Acompañamiento durante el Trabajo de Parto,
3 Nacimiento y Post-parto”, para que lea como sigue:

4 “Artículo 2. — Definiciones

1 Para fines de esta Ley, las siguientes palabras y frases tendrán el
2 significado que a continuación se expresa:

3 a) Acompañantes en las Etapas del Parto: persona o personas que
4 escoja libremente la parturienta, para que la acompañe o asista
5 durante las diversas etapas del parto, entre los cuales se
6 encuentran: madres, padres, familiares[,] y amigos, con o sin
7 adiestramientos, *aparte de la doula* o persona adiestrada en
8 medidas de comodidad *de su elección* [(monitriz, "doula", etc.)].

9 b) ...

10 c) ...

11 d) ..."

12 Sección 2.- Se enmienda el inciso (g) del Artículo 3 de la Ley 156-2006, según
13 enmendada, denominada "Ley de Acompañamiento durante el Trabajo de Parto,
14 Nacimiento y Post-parto", para que lea como sigue:

15 "Artículo 3. — Toda mujer embarazada, durante su embarazo y al
16 momento del trabajo del parto, el parto y el post-parto, tendrá los siguientes
17 derechos:

18 a) ...

19 b) ...

20 c) ...

21 d) ...

22 e) ...

- 1 f) ...
- 2 g) A estar acompañada por *una doula o persona adiestrada en medidas*
3 *de comodidad escogida libremente por ella, además de los familiares,*
4 *amigos o personas de su confianza y elección durante el trabajo de*
5 *parto, en las salas de parto, en el parto y postparto,*
6 *incluyendo el procedimiento de cesárea, en el cual podrá estar*
7 *acompañada por al menos una persona de su elección;*
8 *entendiéndose, sin embargo que la presencia de la(el)*
9 *acompañante o acompañantes no podrá interferir con las*
10 *determinaciones de carácter médico que consideren o tomen los*
11 *profesionales de la salud con responsabilidad en el parto, y en*
12 *caso del procedimiento de cesárea, serán éstos los que*
13 *determinarán en última instancia si permiten o no la presencia*
14 *del acompañante. Además, tendrá derecho a no estar*
15 *acompañada, si así lo desea la mujer. Disponiéndose que el*
16 *acompañante vendrá obligado a cumplir con aquellas reglas que*
17 *tuviere a bien imponer la institución hospitalaria, siempre y*
18 *cuando dichas reglas sean cónsonas a lo establecido en esta Ley.*
- 19 h) ...
- 20 i) ...
- 21 j) ...
- 22 k) ...

1 1) ...”

2 Sección 3.- Cláusula de supremacía.

3 Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición de
4 ley, reglamento o norma que no estuviere en armonía con ellas.

5 Sección 4.- Cláusula de separabilidad.

6 Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada
7 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la
8 ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de
9 dictamen adverso.

10 Sección 5.- Cláusula de vigencia.

11 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.